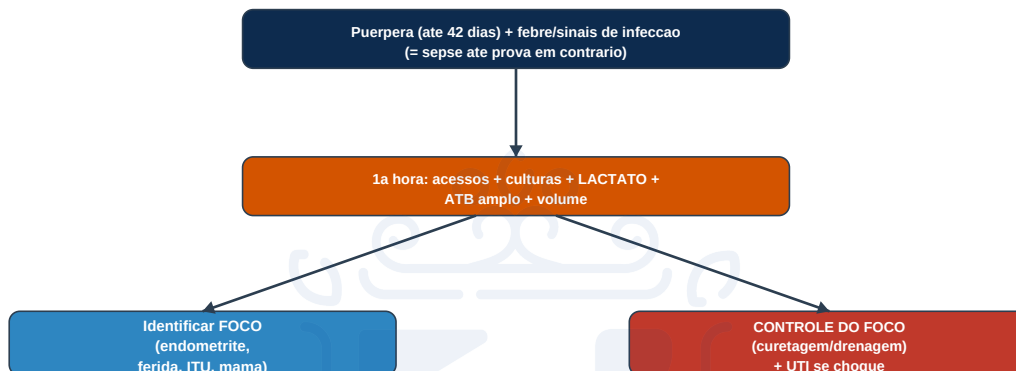


SEPSE PUERPERAL — FOCO + ATB PRECOCE

FLUXOGRAMA — FEBRE NO PUERPÉRIO

SEPSE PUERPERAL — PACOTE DE 1 HORA



DEFINIÇÃO

O QUE É

- Infecção do trato genital ou sistêmica no puerpério (até 42 dias pós-parto) com disfunção orgânica
- Choque séptico: hipotensão persistente apesar de volume + necessidade de vasopressor (PAM ≥ 65) + lactato > 2
- Focos: ENDOMETRITE puerperal (mais comum), infecção de ferida (cesárea/episiotomia), ITU, mastite/abscesso, retenção de restos, ICS
- FEBRE NO PUERPÉRIO = sepse até que se prove o contrário

SINAIS DE ALERTA

RECONHECER A SEPSE

- Febre ≥ 38 C ou hipotermia < 36 C
- Taquicardia > 100 bpm; taquipneia > 22 irpm; hipotensão
- Oligúria; alteração do nível de consciência
- Dor abdominal intensa / secreção (loquiação) fétida
- Lactato elevado

ABORDAGEM INICIAL — PRIMEIRA HORA

Rx PACOTE DE SEPSE

ABCDE; O₂ se SatO₂ $< 94\%$; monitorização; 2 acessos calibrosos; SVD (diurese)
Coletar (sem atrasar ATB): hemograma, LACTATO, creatinina/ureia, TGO/TGP/BT, coagulograma, gasometria se grave
Hemoculturas (2 pares) + urocultura + cultura de secreções (loquiação/ferida)
Reposição volêmica: cristalóide 30 mL/kg se hipotensão ou lactato ≥ 4
Metas: PAM ≥ 65 , diurese $\geq 0,5$ mL/kg/h, lactato em queda; noradrenalina se hipotensão refratária

ANTIBIOTICOTERAPIA + CONTROLE DO FOCO

Rx ATB EM ATÉ 1h

ESQUEMA PADRÃO (endometrite/sepsse ginecológica): Clindamicina 900 mg IV 8/8h + Gentamicina 5-7 mg/kg IV 1x/dia
Alternativas (grave/choque): Piperacilina-tazobactam; Cefepime + Metronidazol; Meropenem (grave/multirresistente)
CONTROLE DO FOCO (essencial): curetagem se restos ovulares; drenagem de abscesso; revisão de ferida operatória;
retirada de corpo estranho
Avaliação cirúrgica precoce
Ajustar ATB conforme culturas/antibiograma

INTERNAÇÃO E COMPLICAÇÕES

UTI / GRAVIDADE

- UTI OBRIGATÓRIA se: choque séptico, necessidade de vasopressor, disfunção orgânica múltipla, rebaixamento de consciência
- Complicações: choque séptico, CVID, insuficiência renal aguda, insuficiência respiratória, óbito materno
- Não retardar o controle do foco (curetagem/drenagem) na instabilidade
- Endometrite é o foco mais comum — avaliar restos ovulares retidos
- Mensagem-chave: febre no puerpério = sepse até prova em contrário; ATB precoce + controle do foco salvam

CHECKLIST NO PS

NÃO ESQUECER

- ☐ Reconhecer febre/sinais de infecção no puerpério como sepse
- ☐ Pacote de sepse na 1a hora (acessos, culturas, lactato, ATB amplo, volume)
- ☐ ATB empírico (clinda + genta) em até 1h
- ☐ Identificar e CONTROLAR o foco (endometrite/ferida/ITU/mama/restos)
- ☐ UTI se disfunção orgânica/choque; reavaliar e ajustar pela cultura

MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Puérpera (___ dias pós-parto, via ___) com sepse; foco provável: ___ (endometrite/ferida/ITU/mama/restos).
- Sinais: febre ___, FC ___, PA ___, lactato ___; disfunção orgânica: ___.
- Pacote de sepse iniciado: ATB (clinda+genta) às ___, volume ___, vasopressor ___.
- Controle do foco: curetagem/drenagem ___. Solicito vaga (UTI se choque) + equipe obstétrica/cirúrgica.

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Puérpera de 5 dias pós-cesárea com febre 38,8, taquicardia, lóquios fétidos e dor uterina. Conduta inicial?

- A) Antitérmico e alta
- B) Pacote de sepse na 1a hora (culturas, lactato, antibiótico amplo, volume) e identificar/controlar o foco
- C) Apenas observação por 24h
- D) Antibiótico oral domiciliar
- E) Aguardar culturas para iniciar antibiótico

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual é o foco infeccioso MAIS comum na sepse puerperal?

- A) Infecção urinária
- B) Endometrite puerperal
- C) Mastite
- D) Pneumonia
- E) Infecção de cateter

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Qual o esquema antibiótico empírico padrão na endometrite/sepse puerperal?

- A) Amoxicilina oral
- B) Clindamicina + Gentamicina endovenosas
- C) Azitromicina dose única
- D) Cefalexina oral
- E) Nitrofurantoína

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Além do antibiótico, qual medida é essencial na sepse puerperal por retenção de restos ovulares?

- A) Apenas antitérmico
- B) Controle do foco (curetagem/esvaziamento uterino)
- C) Restrição hídrica
- D) Corticoide
- E) Observação prolongada

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Qual é a mensagem-chave sobre febre no puerpério?

- A) Febre no puerpério é sempre fisiológica
- B) Febre no puerpério é sepse até que se prove o contrário
- C) Febre no puerpério dispensa investigação
- D) Só investigar após 42 dias
- E) É sempre infecção urinária

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Febre + taquicardia + lóquios fétidos + dor uterina no puerpério = sepse puerperal (provável endometrite). Aplica-se o pacote de sepse na 1ª hora e identifica-se/controla-se o foco. Antibiótico não deve aguardar culturas.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

A endometrite puerperal é o foco mais comum da sepse puerperal, especialmente após cesárea, manifestando-se com febre, dor uterina e lóquios fétidos.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

O esquema padrão para endometrite/sepse puerperal é Clindamicina + Gentamicina EV (cobertura ampla para anaeróbios, Gram + e Gram -); piperacilina/meropenem nas formas graves.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

O controle do foco é essencial: na retenção de restos ovulares, faz-se curetagem/esvaziamento uterino, pois o antibiótico isolado não controla a infecção mantida pelo conteúdo retido.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

A mensagem-chave é: febre no puerpério é sepse até que se prove o contrário — exige investigação ativa do foco e antibioticoterapia precoce.

SM24
Suporte ao Plantão Médico